NEURO · NE-01

AVC ischémique aigu

AHA/ASA 2026

imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

IMAGERIE INITIALE · « LE TEMPS, C'EST DU CERVEAU »

1 · Parenchyme
Scanner sans injection ou IRM (diffusion, FLAIR, T2*) : exclure une hémorragie, évaluer l'infarctus constitué (ASPECTS)

›

2 · Vaisseaux
Angioscanner ou ARM de la crosse aortique au vertex si thrombectomie possible : occlusion d'un gros vaisseau (ACI, M1, M2, tronc basilaire)

›

3 · Perfusion (sélectif)
Scanner ou IRM de perfusion : 6–24 h, heure de début inconnue, viabilité incertaine. Ne doit pas retarder le traitement

Réveil ou heure inconnue : en IRM, un **mismatch diffusion–FLAIR** (lésion visible en diffusion, pas encore en FLAIR) suggère un début < 4,5 h et permet une thrombolyse chez des patients sélectionnés.

ASPECTS (TERRITOIRE DE L'ARTÈRE CÉRÉBRALE MOYENNE)

Partir de **10** et retirer **1 point par région** présentant une hypodensité ou une perte de différenciation précoce.

NIVEAU	10 RÉGIONS
Noyaux gris (coupe thalamo-striée)	C (caudé), L (lenticulaire), IC (capsule interne), I (insula), M1, M2, M3
Supra-ganglionnaire	M4, M5, M6

PC-ASPECTS (circulation postérieure) : 10 points, thalamus 1 chacun, lobe occipital 1 chacun, mésencéphale 2, pont 2, cervelet 1 chacun.

Interprétation

ASPECTS	SIGNIFICATION
6–10	Infarctus constitué limité
3–5	« Large core » : thrombectomie désormais recommandée dans des cas sélectionnés
0–2	Infarctus étendu : thrombectomie seulement dans des cas très sélectionnés

Lecture en fenêtre étroite (W ≈ 40, L ≈ 40), sur coupes fines ou reconstructions.

THROMBECTOMIE · CIRCULATION ANTÉRIEURE (ACI OU M1)

DÉLAI	CRITÈRES	RECOMMANDATION AHA/ASA 2026
0–6 h	NIHSS ≥ 6, mRS préalable 0–1, **ASPECTS 3–10**	**Recommandée** (nouveau, fort impact) ; ASPECTS 0–2 : raisonnable chez des patients sélectionnés
6–24 h	NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS ≥ 6**	**Recommandée**
6–24 h	Âge < 80 ans, NIHSS ≥ 6, mRS 0–1, **ASPECTS 3–5**, pas d'effet de masse significatif	**Recommandée** chez des patients sélectionnés (nouveau)

Tronc basilaire

- Thrombectomie recommandée jusqu'à **24 h** si mRS 0–1, **NIHSS ≥ 10** et **PC-ASPECTS ≥ 6**
- NIHSS 6–9 : bénéfice incertain

Thrombolyse IV

- Dans les **4,5 h** si pas d'hémorragie (altéplase ou ténectéplase)
- Si thrombectomie prévue : ne pas retarder la thrombolyse ni attendre la réponse clinique

COMPTE RENDU : À DONNER EN PREMIER

Hémorragie ?
oui / non, en premier

Occlusion
site exact (ACI, M1, M2, tronc basilaire), tandem, dissection

Infarctus constitué
ASPECTS, volume du cœur ischémique et mismatch si perfusion

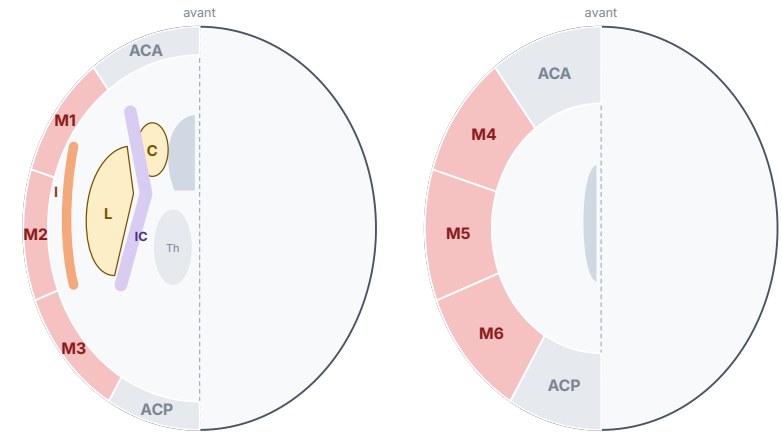
Voie d'abord
crosse, tortuosités, sténose cervicale

NEURO · NE-01

AVC ischémique aigu (suite)

AHA/ASA 2026
imagerie initiale, ASPECTS, fenêtres de thrombolyse et thrombectomie

ATLAS VISUEL · LES 10 RÉGIONS ASPECTS



Niveau des noyaux gris (thalamo-striatal) — Niveau supra-ganglionnaire

Schéma simplifié, non à l'échelle · hémisphère droit du patient à gauche de l'image (convention radiologique)

Comment coter

- Lire sur **2 niveaux** : noyaux gris (thalamus, striatum) et supra-ganglionnaire, juste au-dessus des noyaux
- **Structures profondes** C caudé, L lenticulaire, IC capsule interne (3 points)
- **I** ruban insulaire (1 point)
- **Cortex** M1–M3 au niveau des noyaux, M4–M6 au-dessus (6 points)
- Retirer 1 point par région avec hypodensité ou perte de différenciation substance grise / blanche
- Les territoires ACA et ACP (gris) ne sont pas cotés

ASTUCE

Toute la région doit être examinée sur plusieurs coupes ; une atteinte partielle suffit à retirer le point.

SIGNES PRÉCOCES À RECONNAÎTRE

ACM hyperdense

Segment M1 ou M2 spontanément plus dense que le côté opposé (thrombus). Comparer à l'ACM controlatérale.

Voir un cas ↗

Ruban insulaire

Perte de la différenciation cortex / substance blanche de l'insula, l'un des signes les plus précoces.

Voir l'article ↗

Noyau lenticulaire

Effacement des contours du noyau lenticulaire, hypodensité des noyaux gris (atteinte des perforantes).

Voir des exemples ↗

Mismatch diffusion–FLAIR

Lésion visible en diffusion mais pas encore en FLAIR : début probable < 4,5 h.

Voir un cas ↗

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ASPECTS : article et images
Radiopaedia · régions, exemples annotés, PC-ASPECTS
radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programm

Calculateur ASPECTS
MDCalc · cocher les régions atteintes
www.mdcalc.com/calc/3164/alberta-stroke-program-

Signe de l'ACM hyperdense (cas)
Radiopaedia · thrombus spontanément dense
radiopaedia.org/cases/hyperdense-mca-sign-16

Perte du ruban insulaire
Radiopaedia · signe précoce au scanner
radiopaedia.org/articles/loss-of-the-insular-rib

Mismatch diffusion–FLAIR (cas)
Radiopaedia · infarctus hyperaigu, AVC du réveil
radiopaedia.org/cases/hyperacute-mca-infarct-wit

PC-ASPECTS illustré
Radiopaedia · circulation postérieure
radiopaedia.org/cases/posterior-circulation-acut

Sources : AHA/ASA 2026 Early Management of AIS (Guideline Central) – eguideline.guidelinecentral.com/i/1542862-aha-asa-early-mana... · StatPearls – Acute Stroke (2026) – www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535369/ · Radiopaedia – ASPECTS – radiopaedia.org/articles/alberta-stroke-programme-early-ct-s...